Kosmetik & Fußpflege Anna Roth
Ludwigstraße 9, 93047 Regensburg · 0941 123123 · hallo@kosmetik-roth.example

Hygieneplan

Kosmetik, Nagelstudio und Fußpflege

Rechtsgrundlage	Stand	Verantwortlich
Hygieneverordnung des Landes (§ 17 Abs. 4 IfSG)	**24.10.2026**	**Anna Roth**

Was	Wann / wie oft	Womit	Wie	Wer
Händewaschen	vor Arbeitsbeginn, nach Pausen und dem Essen, nach dem Toilettenbesuch, bei sichtbarer Verschmutzung	Flüssigseife aus Spender (keine Stückseife), Einmalhandtücher	Hände gründlich waschen, abspülen und sorgfältig abtrocknen	alle Beschäftigten
Hygienische Händedesinfektion	vor hautverletzenden oder hautnahen Behandlungen (z. B. Nagelhautbearbeitung, Fußpflege, invasive Kosmetik), nach Ausziehen der Handschuhe, nach Kontakt mit Blut/Körperflüssigkeiten, nach Stich-/Schnittverletzung	VAH-gelistetes alkoholisches Händedesinfektionsmittel	ca. 3–5 ml auf trockene Hände geben, alle Handpartien einreiben und Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten; Einwirkzeit nach Herstellerangabe/VAH-Liste (meist 30 Sekunden)	behandelnde Person
Einmalhandschuhe (Infektionsschutz)	bei möglichem Kontakt mit Blut, Wundsekret oder verletzter Haut; bei verletzenden Tätigkeiten	allergenarme Einmalhandschuhe	für jede Kundin und jeden Kunden neue Handschuhe; bei Beschädigung sofort wechseln; danach Händedesinfektion	behandelnde Person
Hautdesinfektion bei Kundin/Kunde	vor hautverletzenden Eingriffen	VAH-gelistetes, viruswirksames Hautdesinfektionsmittel (Originalgebinde, nicht umfüllen)	auf trockene Haut sprühen oder mit sterilem Tupfer auftragen; Einwirkzeit nach Herstellerangabe einhalten, mindestens 1 Minute; nicht ins Gesicht sprühen	behandelnde Person
Instrumente ohne Verletzungsrisiko (Kämme, Bürsten, Wickler, Scheren, Rasierpinsel)	nach der Behandlung bei Bedarf und bei Arbeitsende; bei Kontakt mit Blut, Sekreten oder unklaren Hautveränderungen sofort	Wasser und fettlösender Reiniger; bei Kontamination VAH-gelistetes Instrumentendesinfektionsmittel nach Herstellerangabe	Haare/Hautschuppen entfernen, nass reinigen, trocknen; bei Blut/Sekret zuerst Tauchdesinfektion (Einwirkzeit abwarten), dann reinigen	Beschäftigte

Was	Wann / wie oft	Womit	Wie	Wer
Instrumente mit Verletzungsrisiko (Rasiermesser, Klingen, Scherköpfe, Nagelhautschere/-zange, Pinzetten, Hautraspeln, Maniküre-/Pediküreinstrumente)	nach jeder Kundin / jedem Kunden	vorzugsweise Einwegklingen; sonst VAH-gelistetes, viruswirksames Instrumentendesinfektionsmittel nach Herstellerangabe (Bayern: mind. begrenzt viruzid)	Einwegartikel nach einmaliger Verwendung entsorgen; Mehrweginstrumente zerlegt und vollständig in die Lösung einlegen (Einwirkzeit ab dem zuletzt eingelegten Teil), abspülen, reinigen, trocknen und geschützt lagern; Lösung bei sichtbarer Verschmutzung sofort, sonst täglich wechseln	Beschäftigte
Instrumente, die die Haut bestimmungsgemäß verletzen bzw. in/unter die Haut gelangen (z. B. Lanzetten, Komedonenheber bei invasiver Anwendung, Fräser bei Wundkontakt)	vor jeder Wiederverwendung	sterile Einwegprodukte oder validiertes Sterilisationsverfahren (vorzugsweise Dampfsterilisation 121 °C oder 134 °C)	reinigen, desinfizieren, spülen, trocknen, prüfen, verpacken (Sterilgutverpackung, Chargen-/Datumskennzeichnung), sterilisieren, geschützt lagern; Sterilisationsparameter dokumentieren	unterwiesene Beschäftigte
Arbeitsplatz / Arbeits- und Ablageflächen	nach jeder Behandlung reinigen; vor jedem hautverletzenden Eingriff reinigen und desinfizieren; mind. täglich; bei Blut-/Sekretkontamination sofort	Reinigungslösung; VAH-gelistetes Flächendesinfektionsmittel nach Herstellerangabe	aufräumen, grobe Verschmutzung entfernen, abwischen; Wischdesinfektion (keine Sprühdesinfektion)	Beschäftigte
Behandlungsliege / Behandlungsstuhl / Kopfstützen	nach jeder Kundin / jedem Kunden	Reinigungsmittel, frische Einmal- oder Stoffunterlage; bei Kundin/Kunde mit Hautinfektion bzw. Kontamination VAH-gelistetes Flächendesinfektionsmittel	Unterlage wechseln, Flächen abwischen; bei Kontamination wischdesinfizieren	Beschäftigte
Waschbecken (Haarwaschbecken, Handwaschbecken, Sanitär)	nach jeder Behandlung bzw. mind. arbeitstäglich; nach Kontamination	Reinigungslösung; bei Kontamination mit Körperflüssigkeiten Desinfektionsmittel	reinigen; nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten desinfizieren	Beschäftigte
Fußboden	täglich nach Arbeitsende (Friseur: grob nach jeder Behandlung); bei Blutkontamination sofort	Reinigungslösung, sauberer Wischbezug; bei Kontamination Flächendesinfektionsmittel	ausfegen, feucht wischen; Blut zuerst mit getränktem Einmaltuch/Zellstoff aufnehmen, dann wischdesinfizieren	Beschäftigte / Reinigungskraft

Was	Wann / wie oft	Womit	Wie	Wer
Wäsche: Handtücher, Kundenumhänge, Abdecktücher, Arbeitskleidung	nach jeder Kundin / jedem Kunden	Vollwaschmittel bzw. desinfizierendes Waschverfahren	in Wäschebeutel/-behälter sammeln, getrennt von Reinigungstüchern; bei mindestens 60 °C waschen, danach möglichst im Trockner trocknen; Umhänge nur mit Papierhalskrause verwenden; mit Blut oder Sekret verschmutzte Wäsche bei mindestens 60 °C waschen oder entsorgen	Beschäftigte
Reinigungsutensilien (Wischlappen, Bodentücher, Wischbezüge)	täglich nach der Reinigung	Vollwaschmittel; Haushalts- oder langstulpige Handschuhe	bei mindestens 60 °C waschen; Besen von Haaren befreien	Beschäftigte
Abfall allgemein	laufend; Behälter täglich leeren	Abfallbehälter mit Deckel (fußbedient bzw. berührungsfrei) und flüssigkeitsdichtem Kunststoffsack	am Arbeitsplatz sammeln; blutbehaftete Abfälle in feuchtigkeitsdichten Behältern	Beschäftigte
Spitze, scharfe, zerbrechliche Gegenstände (Klingen, Lanzetten, Kanülen)	unmittelbar nach Gebrauch	stich- und bruchfester, verschließbarer Behälter	direkt einwerfen, Schutzkappe nicht wieder aufsetzen; Behälter fest verschließen und über den Hausmüll entsorgen	behandelnde Person
Umgang mit Blut – Verletzung von Kundin/Kunde	bei unbeabsichtigter Verletzung	Einmalhandschuhe, steriler Tupfer, zugelassenes Wund-/Hautantiseptikum, Pflaster	Blutung nicht mit ungeschützten Händen berühren; mit sterilem Tupfer und leichtem Druck stillen, Wunde desinfizieren und mit Pflaster versorgen; größere Wunden ärztlich versorgen lassen; kontaminierte Flächen und Instrumente sofort desinfizieren	behandelnde Person
Umgang mit Blut – Stich-/Schnittverletzung der beschäftigten Person	sofort nach Verletzung	Hautantiseptikum (VAH-gelistet), Verbandmaterial, Verbandbuch	Blutfluss fördern, Wunde mind. 1 Minute desinfizieren, abdecken und sofort Durchgangsarzt bzw. Betriebsarzt aufsuchen – eine HIV-Postexpositionsprophylaxe sollte möglichst innerhalb von 2 Stunden beginnen, nach einer Stich- oder Schnittverletzung spätestens bis 24 Stunden; auch später noch ärztlich abklären lassen. Kundin/Kunde fragen, ob sie freiwillig Auskunft über bekannte Infektionen (Hepatitis B/C, HIV) geben möchten – die Antwort ist freiwillig; nur an den Durchgangsarzt weitergeben, nicht im Verbandbuch notieren. Unfall im Verbandbuch dokumentieren.	betroffene Person / Arbeitgeber
Hygieneplan pflegen und	jährlich überprüfen und	schriftlicher bzw. elektronischer	Plan jederzeit einsehbar halten; Unterweisung der	Inhaber/in

Was	Wann / wie oft	Womit	Wie	Wer
Personal unterweisen	aktualisieren; Unterweisung mind. jährlich	Hygieneplan, Unterweisungsnachweis	Beschäftigten schriftlich dokumentieren	

Ort, Datum

Unterschrift Verantwortliche/r